

Sindromi Affettive e Sindromi Ansiose

— Sintesi

Salute Mentale · Sessione 06

Lezione densa ma fondamentale: emozioni → depressioni → bipolari → ansia. Tienila come mappa prima di qualsiasi ripasso.

Le emozioni

- **Emozione:** reazione affettiva acuta e breve, generata da un evento stimolo (Galimberti, 1999)
- **Umore:** disposizione affettiva di fondo, più persistente, non legata a un evento specifico (Delay, 1946)
- Funzioni: adattamento all'ambiente + comunicazione con gli altri
- Le emozioni non sono né positive né negative — diventano problematiche solo se eccessive o durature

Emozioni di base — Ekman e Friesen (1971): - Gioia, tristezza, paura, disgusto, rabbia, sorpresa - Universali come *tema*; l'*espressione* varia con la cultura

Modello di Plutchik (2017) — fiore multidimensionale: - 8 emozioni primarie (non 6) - Intensità variabile lungo i petali (es. tristezza → angoscia → pensierosità) - Emozioni secondarie dalla combinazione di due primarie (rabbia + disgusto = disprezzo)

Le depressioni

- La tristezza è normale e funzionale — la depressione è uno stato patologico che inibisce le risposte emotive
- Esistono **le** depressioni (forme diverse, cause diverse, trattamenti diversi)

Nucleo semiologico comune (Melanie Klein): - Umore depresso (tono timico abbassato) - Rallentamento psicomotorio (gesti, voce, andatura) - **Anedonia depressiva** = assenza di piacere per attività abitualmente piacevoli (sintomo soggettivo) - Rallentamento psichico (attenzione, memoria, concentrazione) - Apatia (assenza di motivazione) — diversa dall'anedonia

Alfa privativo: prefisso "a-" nel vocabolario medico = quella cosa non c'è (a-nedonia, a-patia, a-bulia...)

Classificazione di Lalli (2002):

Categoria	Origine	Nota
Depressioni primarie	Carattere depressivo (bassa autostima, dipendenza, rabbia repressa)	La persona si sente vittima (psicogene) o colpevole (endogene)
Depressioni secondarie	Causa organica (malattia, farmaci, neurologica)	Va trattata anche la depressione, non solo la causa organica

Tre gruppi clinici: - **Psicogene:** causa comprensibile (lutto, trauma, ferita narcisistica); persona reattiva all'ambiente; si sente vittima - **Endogene/melanconiche:** causa interna non identificabile; persona si sente colpevole; anamnesi familiare spesso positiva; perdita di reattività - **Di origine somatica:** causa organica

Depressione mascherata: malessere depressivo espresso solo con sintomi somatici (≠ ipocondria, che è ansia per la salute)

Disturbo depressivo maggiore: episodi distinti ≥ 2 settimane; remissioni interepisodiche possibili; non interrompere la terapia all'eutimia

Disturbo depressivo persistente: abbassamento cronico ≥ 2 anni senza ritorno all'eutimia; depressione meno marcata ma continua

Disturbi bipolari

- Oscillazione repentina tra due poli estremi: **depressione** ↔ **mania** (o ipomania)
- Immagine chiave: **pendolo timico** — eutimia al centro, depressione e mania agli estremi

Episodio maniacale: - Euforia eccessiva, insonnia senza stanchezza, agitazione psicomotoria, logorrea - Fuga di idee, deliri di grandezza, dispendio economico, disinibizione sociale/sessuale - **Perdita di contatto con la realtà** — non è solo umore alto

Episodio depressivo nel bipolare: simile al disturbo maggiore, ma **non trattare con antidepressivi** (rischiano di scatenare la fase maniacale) → usare **stabilizzatori dell'umore** (litio o anticonvulsivi)

Tipo	Alternanza
Bipolare I	Depressione ↔ Mania
Bipolare II	Depressione ↔ Ipomania (meno intensa, non meno grave)
Ciclotimico	Fluttuazione continua ≥ 2 anni senza criteri pieni per nessuna fase

Psicoeducazione: il paziente tende a sospendere i farmaci all'eutimia → rischio recidiva. Il litio richiede monitoraggio ematico regolare. I familiari sono una risorsa chiave.

Le sindromi ansiose

Paura vs. Ansia: - **Paura** = pericolo concreto, presente, identificabile → risposta di emergenza (lotta/fuga) - **Ansia** = minaccia indefinita, futura, ipotetica → ipervigilanza, evitamento - Entrambe normali e funzionali; diventano patologiche se sproporzionate e durature

Rimuginio ansioso (Borkovec et al.): - Costruzione mentale ripetuta di scenari negativi futuri in condizione di incertezza - Caratteristica principale del **Disturbo d'ansia generalizzato (DAG)** - Paradosso: più si rumina per abbassare l'ansia, più si alimenta - Cronico → tensione muscolare, disturbi del sonno, dolori fisici

Ruminazione depressiva (≠ rimuginio): orientata al passato, analizza cause di eventi già accaduti

Sintomi dell'ansia (4 livelli): - **Cognitivo:** ipervigilanza, distraibilità, paura di perdere controllo/morire - **Affettivo:** irritabilità, inquietudine, oppressione - **Fisiologico:** tachicardia, iperventilazione, tremori, nausea, tensione muscolare - **Comportamentale:** evitamento, agitazione, ricerca di rassicurazione (web → controproducente)

Principali disturbi d'ansia (DSM-5-TR): - Disturbo d'ansia generalizzato (DAG) - Disturbo d'ansia sociale (timore giudizio; emozione centrale: vergogna) - Disturbo di panico (attacchi ricorrenti inaspettati; picco in pochi minuti; ≥ 4 sintomi) - Agorafobia, Fobia specifica, Ansia da separazione, Mutismo selettivo

DOC e PTSD **non** sono nei disturbi d'ansia nel DSM-5-TR — hanno capitoli propri.

Attacco di panico: paura intensissima + sintomi fisici marcati + convinzione di morire. Non si muore dall'attacco, ma la risposta impulsiva può creare rischi. Accoglienza senza giudizio.

Ansia di stato vs. ansia di tratto (Sims e Snaith): - Stato = episodica, legata a situazione specifica - Tratto = modalità stabile, costante; spesso associata a disturbi di personalità

Da ricordare:

1. Anedonia ≠ Apatia — la prima è assenza di piacere, la seconda di motivazione. Spesso coesistono.

2. Depressioni psicogene vs. endogene: la persona si sente *vittima* (psicogene) o *colpevole* (endogene) — cambia tutto: stimolazione, relazione terapeutica, risposta al trattamento.

3. Nel bipolare non dare antidepressivi in fase depressiva — rischio di scatenare la mania. Stabilizzatori dell'umore.